혈구 수치와 치료 이력

혈액검사의 이상 표시는 병명과 같지 않습니다. 항암치료를 받았다면 마지막 치료일과 백혈구 촉진 주사 여부를 함께 알려주세요.

항암 뒤 백혈구 수가 바뀌는 과정

항암치료 → 다음 날 peg-G-CSF → 수일간 백혈구 상승 가능

백혈구 촉진 주사 뒤 일시적으로 수치가 오르고 골통이 생길 수 있지만 발열·오한은 별도로 평가합니다.

항암치료 중 수치가 낮다면 · 정재호 강의

항목	판단할 내용
혈색소(Hb)	강의는 Hb <8.0 g/dL 또는 증상·빈맥·어지럼·활동 저하 시 수혈 판단과 의뢰를 설명합니다.
혈소판(PLT)	50,000/μL 미만은 출혈위험, 20,000/μL 미만은 응급 의뢰 대상입니다.
백혈구·호중구	백혈구가 낮고 발열이 동반되면 호중구감소성 발열을 고려해 응급 평가합니다.

백혈구 촉진 주사를 맞은 뒤

가능한 변화	바로 평가할 신호
일시적 백혈구 증가·허리/골반 골통	발열·오한·국소 감염징후
골수 증식에 따른 통증	호흡곤란·부종·저혈압·좌상복부 통증
수일 사이 추세 변화	백혈구 50,000~100,000/μL를 넘는 초고도 증가

- 항암제 이름·마지막 투여일을 알려주세요.
- 해열제와 백혈구 촉진 주사를 맞았는지 알려주세요.

위 수치는 항암치료 환자에 대한 강의의 의뢰 판단입니다. 일반 건강검진의 참고범위와 혼동하지 마세요. 항암 중 ≥38.3°C 또는 ≥38.0°C가 1시간 이상 지속되면 응급 평가를 받습니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30–18:30 (점심 13:00–14:00) · 토 08:30–13:30 · 일·공휴일 휴진

아산 28회 연수강좌 — 암 환자가 우리 병원에 왔을 때: 개원의를 위한 증상 관리 가이드(정재호)
아산 28회 연수강좌 — 자가항체 검사 해석의 핵심 포인트(홍석찬)

종양표지자·자가항체는 숫자만으로 진단하지 않아요

의심되는 질환과 증상이 있을 때 검사를 선택하고, 양성 결과도 진찰과 함께 해석합니다.

검사 결과를 읽는 두 가지 축

검사값·항체 역가 → 증상·진찰·치료 이력 → 추가 검사·추적 결정

수치 하나보다 임상 상황과 시간에 따른 변화를 연결합니다.

자가항체 결과의 뜻 · 홍석찬 강의

검사	해석
류마티스 인자(RF)	양성만으로 류마티스관절염을 진단하지 않고, 음성만으로 배제하지 않습니다. 고령·감염에서도 양성일 수 있습니다.
항핵항체(ANA)	건강인·갑상선질환·간질환·감염 등에서도 양성일 수 있습니다. 단순 양성/음성보다 역가와 증상이 중요합니다.
항CCP항체(ACPA)	RF보다 류마티스관절염 특이도가 높지만, 관절 부종 등 임상 상황에서 해석합니다.

종양표지자와 암 치료 후 검진 · 정재호 강의

구분	원칙
암 선별 목적	일반적인 혈중 종양표지자를 무증상자의 암 선별검사로 사용하지 않습니다.
암 생존자 관리	재발 감시·이차암 검진·후기 독성과 건강증진을 구분하고 치료기관 일정과 연계합니다.
새 증상 발생	체중감소·지속되는 뼈통증·두통·신경학적 이상·출혈은 지체 없이 평가합니다.

진료에 알려줄 증상

관절 부종·아침 뻣뻣함, 입·눈 마름, 추위에 변하는 손끝 색, 피부 발진 등을 함께 설명하세요.

양성이라고 약부터 시작하지 않아요

검사 목적, 항체 종류·역가, 진찰 소견을 연결해 추가 검사와 추적을 결정합니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30–18:30 (점심 13:00–14:00) · 토 08:30–13:30 · 일·공휴일 휴진

아산 28회 연수강좌 — 암 환자가 우리 병원에 왔을 때: 개원의를 위한 증상 관리 가이드(정재호)
아산 28회 연수강좌 — 자가항체 검사 해석의 핵심 포인트(홍석찬)

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/checkup-blood-test-guide/